HELP_Organi_P02 — Critique — 17 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 2 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

A-079 — Critique — LOT 8 · SSP G8

Emplacement : LOT_8_Appel_A_V6_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › tableau comparatif › ligne DX.3 › conduite immédiate ; constats L8-M25, L8-L25

Contexte : Le tableau comparatif cite Euthyrox® (comprimés) pour le coma myxœdémateux, sans dose ; aucune lévothyroxine IV autorisée en Suisse n'a été trouvée ; l'audit cite L-Thyroxin SERB® 200 µg/mL (Allemagne, 200–500 µg IV le premier jour).

Question : Existe-t-il en 2026 une lévothyroxine ou une liothyronine IV autorisée en Suisse, ou faut-il l'importer (art. 49 OAMéd) ? Quelle dose de charge et d'entretien IV, quelle hydrocortisone préalable et quelles précautions (sujet âgé, coronaropathie) recommande la source européenne la plus récente (ETA) pour le coma myxœdémateux ? Indique la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL), compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; donne doses, voies, durées et adaptations (rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse) selon l'AIPS (swissmedicinfo.ch) ; à défaut de source suisse, cite la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-021 — Critique — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_228_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 2 › tableau charge virale CMV ; Partie 2 › DX.4 (CMV) › tableau des critères et « Interprétation : hémogramme avant valganciclovir »

Contexte : Le cours écrit que les seuils chiffrés de charge virale CMV n'ont pas été trouvés. Il cite comme limites du valganciclovir des plaquettes < 25 000/µl et une hémoglobine < 8 g/dl (IP de Valcyte®).

Question : Quels seuils de charge virale CMV (UI/ml, standard OMS) déclenchent le traitement préemptif après transplantation d'organe solide et de cellules souches, selon la Swiss Transplant Cohort Study, l'ECIL et le consensus international le plus récent ? Donne les doses de valganciclovir et de ganciclovir, avec l'adaptation rénale selon l'IP suisse. Vérifie dans l'IP suisse actuelle de Valcyte® les seuils de PNN, de plaquettes et d'hémoglobine qui contre-indiquent le traitement. Quelles sont les définitions de la maladie à CMV « probable » (Ljungman 2017 ou mise à jour) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-024 — Critique — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.7 (tuberculose) › tableau IGRA, fenêtre « doses à la pesée » et lacunes

Contexte : Le cours calcule les doses antituberculeuses (isoniazide 5 mg/kg max 300 mg, rifampicine 10 mg/kg max 600 mg, pyrazinamide 25 mg/kg max 2 g, éthambutol 15 ou 25 mg/kg). Il n'a trouvé ni le plafond en mg de l'éthambutol, ni le seuil chiffré de l'IGRA, ni le délai minimal entre le début du traitement de l'infection latente et l'anti-TNF.

Question : Selon le manuel suisse de la tuberculose (Ligue pulmonaire suisse/OFSP, édition la plus récente) et l'IP suisse de Myambutol®, quelle est la dose maximale d'éthambutol en mg/jour ? Quel seuil de positivité (UI/ml) utilisent les IGRA disponibles en Suisse (QuantiFERON-TB Gold Plus, T-SPOT.TB) ? Combien de temps de traitement de l'infection latente faut-il avant de débuter un anti-TNF, et quels schémas sont recommandés (3HR, 4R, 9H) ? Donne les différences avec le guide 2024 cité.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-026 — Critique — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_228_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › fenêtre « corps de Howell-Jolly » ; Partie 4 › DX.9 (OPSI) › diagnostics différentiels (paludisme, méningite), tableau frottis sanguin, pronostic

Contexte : Le cours écrit que la fièvre suffit à traiter l'asplénique et que l'OPSI a une létalité d'environ 50 %. Il ne précise ni la conduite face à une méningite (antibiotique avant ou après la

ponction lombaire), ni le diagnostic du paludisme, ni le nombre de corps de Howell-Jolly qui signe l'hyposplénie.

Question : Selon la recommandation suisse la plus récente (OFSP/CFV sur l'asplénie, SSI), quels sont l'antibiotique empirique et sa dose en cas de fièvre chez un asplénique, ainsi que l'antibiothérapie de réserve à domicile ? Quelles vaccinations faut-il ? En cas de suspicion de méningite bactérienne, quand administre-t-on l'antibiotique et la dexaméthasone par rapport au scanner et à la ponction lombaire (ESCMID 2016 ou mise à jour) ? Quel test diagnostique du paludisme recommande-t-on en urgence en Suisse ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-030 — Critique — LOT 229 · SSP O7.7

Emplacement : LOT_229_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_229_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 2 › fenêtre « choc anaphylactique » et ligne « Grossesse » ; Partie 1 › DX.2 › tableau adrénaline ; Partie 3 › fenêtre « Fiche Epipen®/Jext® complète »

Contexte : Le cours donne les doses des auto-injecteurs (Epipen® 0,3 et 0,15 mg ; Jext® 300 et 150 µg ; seuils de poids 30, 15 et 7,5 kg ; 2e injection après 5 à 15 min). Il n'a vérifié ni la spécialité suisse de l'ampoule hospitalière, ni l'adaptation rénale ou hépatique, ni l'adaptation des tests en grossesse. Il écrit que Neffy® et Emerade® sont absents de la LS.

Question : Quelle spécialité suisse d'adrénaline en ampoule (1 mg/ml) sert à l'injection IM hospitalière, et quelle dose donne son IP (0,01 mg/kg, maximum 0,5 mg adulte) ? Les IP suisses d'Epipen® et de Jext® prévoient-elles une adaptation rénale ou hépatique ? Neffy® (adrénaline nasale) est-il autorisé par Swissmedic au 22.10.2026 ? Quelle conduite face à l'anaphylaxie recommandent les recommandations suisses (SSAI/aha!) et l'EAACI 2026, et quelles différences présentent-elles avec les versions citées ? Que recommande-t-on pour l'anaphylaxie pendant la grossesse ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-061 — Critique — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.7 (BMR) › tableau des traitements (ligne 5. Infection à EPC) et fenêtre MERINO

Contexte : Le cours écrit que l'infectiologue choisit selon l'antibiogramme et le type de carbapénémase ; le texte intégral ESCMID était inaccessible, et aucun schéma ni dose n'est donné. Il cite MERINO contre la pipéracilline/tazobactam dans la bactériémie à BLSE.

Question : Quels traitements recommande la ligne directrice ESCMID 2022 sur les bacilles Gram négatifs multirésistants (ou sa mise à jour) pour les infections à E-BLSE et à EPC selon le type de carbapénémase (KPC, OXA-48, NDM/métallo-β-lactamases) : ceftazidime-avibactam, méropénem-vaborbactam, aztréonam-avibactam, céfidérocol, imipénem-relebactam ? Donne les doses et les

adaptations rénales selon les IP suisses. Précise leur statut Swissmedic et LS et la recommandation suisse éventuelle (SSI, Swissnoso).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-063 — Critique — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › fenêtre « justification du rang » (DX.9) ; Partie 4 › DX.9 (fièvre non infectieuse) › tableau hyperthermie maligne et tableau des traitements (dantrolène, énoxaparine)

Contexte : Le cours cite Agilus® 120 mg (dantrolène) : 2,5 mg/kg IV, puis 2,5 mg/kg toutes les 10 min. Il n'a trouvé ni les critères formels de l'hyperthermie maligne, ni la référence diagnostique, ni le texte intégral des recommandations ESC 2019 sur l'embolie pulmonaire.

Question : Selon l'IP suisse d'Agilus® et la recommandation EMHG (European Malignant Hyperthermia Group) la plus récente, quelle est la dose de dantrolène : dose initiale, répétitions, dose cumulée maximale, relais ? Quels critères cliniques (score de Larach) et quelle référence diagnostique (test de contracture in vitro) retient-on ? Existe-t-il une ligne d'urgence ou un centre de référence suisse pour l'hyperthermie maligne ? Les recommandations ESC 2019 sur l'embolie pulmonaire ont-elles été remplacées par une version plus récente, et avec quelles différences ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-065 — Critique — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.10 (exposition au sang) › tableau créatinine/ALT, « informations professionnelles : mécanisme, adaptations, interactions », « immunoglobulines et vaccin : tableau », recherche 2026

Contexte : Le cours suit les recommandations suisses PEP (CFIST/OFSP) : remplacement du ténofovir disoproxil par le ténofovir alafénamide 25 mg si DFGe < 50 ml/min, immunoglobulines anti-HB Behring® 12 UI/kg (minimum 500 UI IM) selon la seule posologie CFIST. L'IP des immunoglobulines n'a pas été trouvée, ni certaines adaptations rénales et hépatiques des antirétroviraux.

Question : Quelle est la recommandation suisse en vigueur sur la PEP après exposition professionnelle au VIH, au VHB et au VHC (OFSP/CFIST, Swissnoso, SUVA ; titre, année, URL) ? Quel schéma antirétroviral prévoit-elle (molécules, doses, durée de 28 jours, délai ≤ 72 h, idéalement en 2 h) ? Quelles différences présente-t-elle avec la version citée ? Donne, selon les IP suisses, les adaptations rénales et hépatiques de chaque antirétroviral du schéma. Donne la posologie des immunoglobulines anti-HBs (Hepatitis-B-Immunoglobulin Behring® ou spécialité actuelle) selon l'IP suisse. Quel suivi sérologique (VIH, VHB, VHC) et à quelles échéances faut-il ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :

3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-018 — Critique — LOT 233 · SSP O7.11 ; O7.14

Emplacement : LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_236_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 233 Plan et Liste › III.A. Hypothèses fréquentes et graves › Idées suicidaires (lacune #6) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › idées suicidaires (lacune #40) ; LOT 236 Plan et Liste › BLOC 2 — Les dix situations cliniques DX.1 à DX.10 › faiblesse acquise en réanimation Neuropathie et/ou myopathie acquises (lacune #11) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè › idées de mort ou de suicide (lacune #99)

Contexte : Le cours signale les idées suicidaires comme drapeau rouge (examen psychiatrique, PAFA possible selon CC 426) mais n'indique aucune échelle ni évaluation structurée suisse du risque suicidaire.

Question : Quelle évaluation structurée du risque suicidaire recommandent les sources suisses (SSPP, recommandations FMH/ASSM, programmes cantonaux, OFSP « Plan d'action prévention du suicide ») et européennes (EPA) ? Quelles échelles (C-SSRS, item 9 du PHQ-9, autres) sont utilisées, avec quels seuils et quelle conduite (hospitalisation, PAFA) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-019 — Critique — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 233 Plan et Liste › III.A. Hypothèses fréquentes et graves › Dyspnée, douleur, anxiété (lacune #7) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › Douleur, dyspnée, anxiété, agitation, confusion (lacune #66) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) (lacune #67) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 9.c.1 : enfant, adolescent, démence, imagerie (lacune #69) ; LOT 233 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 233 : Refus de traitement (O7.11) › 🔍 Fenêtre Interactive 11.B.2 : médicaments (classe, DCI, spécialité su (lacune #70)

Contexte : Le cours dit que le médecin traite de façon préventive la dyspnée, la douleur et l'anxiété après interruption d'une mesure de maintien en vie, sans échelle, sans molécule ni dose (« donnée non trouvée »).

Question : Quelles recommandations suisses (palliative ch / bigorio, directive ASSM « Soins palliatifs », version la plus récente) fixent les médicaments, doses et voies pour la dyspnée, la douleur, l'anxiété, l'agitation et la sédation palliative (morphine, midazolam, halopéridol, lévomépromazine, scopolamine) et les échelles d'évaluation (ESAS, RASS, BPS) ? Comment adapter les doses en insuffisance rénale ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre,

organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-021 — Critique — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 233 Plan et Liste › III.A. Hypothèses fréquentes et graves › Syndrome de renutrition (lacune #8) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › Poids et indice de masse corporelle (lacune #117)

Contexte : Le cours décrit le dépistage du syndrome de renutrition (IMC bas, perte de poids importante, apport faible > 10 jours, alcool) et une reprise progressive avec électrolytes, sans seuil chiffré de kcal/kg/j ni de phosphatémie ; il cite un algorithme suisse [S404].

Question : Quels critères chiffrés de risque (IMC, % de perte de poids, jours de jeûne, électrolytes) et quel protocole de réalimentation (kcal/kg/j aux jours 1–3, montée, cibles et substitution de phosphate, potassium, magnésium) recommandent l'algorithme suisse de syndrome de renutrition (Friedli et al., SSNC/GESKES) et l'ESPEN la plus récente ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-022 — Critique — LOT 233 · SSP O7.11

Emplacement : LOT_233_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 233 Plan et Liste › III.A. Hypothèses fréquentes et graves › Syndrome de Wernicke-Korsakoff (lacune #9) ; LOT 233 Plan et Liste › 7.1. Patient à capacité douteuse (DX.1) › encéphalopathie (lacune #10) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › thiamine (pyrophosphate de thiamine) (lacune #118)

Contexte : Le cours donne Benerva® (thiamine) : 200–300 mg au plus tard 30 min avant la réalimentation (algorithme suisse), 100 mg/j p.o. si symptômes modérés, 200–300 mg/j si graves ; seuls les comprimés 100 mg figurent dans la liste des spécialités ; les critères diagnostiques de Wernicke manquent.

Question : Quelles formes injectables de thiamine sont autorisées ou disponibles en Suisse en 2026, et quelle dose i.v. recommandent les sources européennes (EFNS, ESPEN) pour suspicion d'encéphalopathie de Wernicke ? Quels sont les critères diagnostiques de Caine ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-032 — Critique — LOT 233 · SSP O7.11 ; O7.13

Emplacement : LOT_233_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html ; LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › infection tuberculeuse (lacune #96) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › Alternatives selon le terrain (lacune #100) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › éthambutol (lacune #101) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) (lacune #102) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) (lacune #103) ; LOT 233 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 233 : Refus de traitement (SSP O7.11) › Recherche 2026 (lacune #104) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #12) ; LOT 235 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #69) ; LOT 235 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #70) ; LOT 235 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S6] (lacune #71) ; LOT 235 Partie 2 DX.3 a DX.5 › Lacunes restantes (lacune #80)

Contexte : Le cours donne le schéma 2 HRZE + 4 HR, la surveillance des expectorations à la fin du 2e et avant la fin du 5e mois, le BPaLM 6 mois pour la TB-MR avec le groupe d'experts MDR-TB, les six catégories de résultat OMS ; il ne donne ni les spécialités suisses, ni les critères formels de guérison OMS, ni le choix de l'imagerie pendant la grossesse ; la fréquence du refus de traitement n'est pas connue.

Question : Quelles spécialités antituberculeuses sont autorisées en Suisse (Rimactan®, Rifinah®, Rifater®, Myambutol®, pyrazinamide, bédaquiline Sirturo®, prétomanide, linézolide) et à quelles doses par kg ? Quels sont les critères OMS 2021–2025 de guérison et de traitement terminé ? Comment le manuel suisse règle-t-il la radiographie thoracique pendant la grossesse, le refus de traitement (LEp art. 35–37, isolement) et le traitement directement observé ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-033 — Critique — LOT 234 · SSP O7.12 ; O7.13

Emplacement : LOT_234_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html ; LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 234 Plan et Liste › Bloc 1

— Monographie du SSP › métronidazole Mécanisme. Ce nitro-imidazole inhibe la synthèse des aci (lacune #0) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #56) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S36] [S38] [S5] (lacune #14) ; LOT 235 Plan et Liste › Lacunes restantes (lacune #22) ; LOT 235 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S36] [S200] [S201] (lacune #74)

Contexte : Le cours donne : PPE hépatite B par immunoglobulines anti-HBs 500 UI i.m. si possible ≤ 48 h (inutiles après 7 jours) + vaccin accéléré (Engerix-B® 20) ; chronique : ténofovir alafénamide Vemlidy® 25 mg 1×/j ; aiguë sévère : lamivudine ou entécavir ; seuils de traitement EASL 2025 lus en résumé ; statut suisse du bepirovirsen inconnu.

Question : Quelle immunoglobuline anti-HBs est autorisée ou disponible en Suisse (Hepatect® CP, Hepatitis-B-Immunglobulin Behring, autre) et à quelle dose pour la PPE de l'adulte et du nouveau-né ? Quels sont les critères de traitement de l'hépatite B chronique selon l'EASL 2025 (ADN VHB, ALAT, fibrose kPa) comparés à l'EASL 2017 et à la recommandation suisse (SASL/OFSP) ? Le bepirovirsen a-t-il une autorisation Swissmedic ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-042 — Critique — LOT 234 · SSP O7.12 ; O7.13

Emplacement : LOT_234_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 234 Plan et Liste › Bloc 1 — Monographie du SSP › 🔍 Fenêtre Interactive 12.7 : Propagation d’une maladie (CP 231) et act (lacune #2) ; LOT 234 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (situation de › Alternatives selon la situation (lacune #11) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Code civil (CC) art. 314c, 314d et CP art. 321 (lacune #122) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › Lacunes restantes (lacune #133)

Contexte : Le cours cite les CC 314c (droit d'aviser) et 314d (obligation d'aviser) et le CP 187 (exception de l'écart d'âge de trois ans) ; la conduite chez l'enfant plus âgé atteint d'IST, les obligations de protection de l'enfant et l'obligation cantonale d'aviser à Neuchâtel ne sont pas données.

Question : Quelle conduite recommandent les sources suisses (Pédiatrie suisse, groupes de protection de l'enfant des hôpitaux, Protection de l'enfance Suisse) devant une IST chez un enfant ou un adolescent (suspicion d'abus, examens, signalement à l'APEA) ? Quelles obligations d'aviser fixe le droit cantonal neuchâtelois (loi de santé, loi sur la protection de l'enfant) en plus des CC 314c–314e ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-052 — Critique — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 235 Plan et Liste › Lacunes restantes (lacune #21) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Artésunate IV (lacune #105) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #107) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #108) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Lacunes restantes (lacune #112) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Lacunes restantes (lacune #113)

Contexte : Le cours suit l'ESCMID : artésunate i.v. 2,4 mg/kg à H0, H12, H24 puis 1×/j ; quinine i.v. de repli (charge 20 mg/kg en 4 h puis 10 mg/kg/8 h) ; chloroquine de première ligne pour le paludisme non falciparum, alors que la liste Swissmedic ne contient pas de chloroquine seule ; aucune ligne directrice suisse du paludisme n'a été trouvée.

Question : Quelles recommandations suisses existent pour le traitement du paludisme (Swiss TPH, Société suisse d'infectiologie, CEMV/OFSP, année) ? Comment obtient-on l'artésunate i.v. et la quinine i.v. en Suisse (autorisation, importation art. 49 OAMéd, hôpitaux de référence) ? Quelles spécialités et doses suisses s'emploient pour le paludisme simple (artéméther-luméfantrine Riamet®, atovaquone-proguanil Malarone®) et non falciparum (hydroxychloroquine, chloroquine importée) ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-053 — Critique — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › dosage de la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (lacune #103) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › dosage de la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (lacune #104)

Contexte : Le cours exige le dosage de la G6PD avant la primaquine (contre-indiquée en cas de déficit ; schéma hebdomadaire OMS si déficit léger), sans seuil d'activité enzymatique ; le statut suisse de la primaquine n'est pas vérifié.

Question : Quels seuils d'activité G6PD (% de la normale, U/g Hb) recommandent l'OMS et les sources européennes pour la primaquine et la tafénoquine ? Quelle dose de primaquine (0,25 ou 0,5 mg/kg/j, 7 ou 14 jours) et comment l'obtenir en Suisse ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P02 — 17 questions : A-079, B-021, B-024, B-026, B-030, B-061, B-063, B-065, C-018, C-019, C-021, C-022, C-032, C-033, C-042, C-052, C-053